



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : هاله سلامه علي سعد

المحافظة : القليوبية الحي / المدينة : القناطر الخيرية العنوان :

رقم البطاقة : 27004251401966 رقم التليفون : 01005095354 تاريخ تسجيل الإستمارة : 21-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 25-04-1970 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: التوقيع:
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: التوقيع:
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: التوقيع:
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هاله سلامة علي سعد National ID: 27004251401966	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

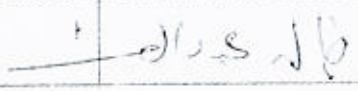
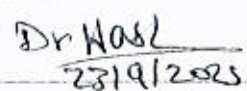
التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



MDT FORM

Patient Name	هالة سلامة علي محمد	Age	52
Sex	F	Special habits	
Family History		Comorbidity	
Surgical History		Telephone	01008769820
Menopausal Status		Marital Status	
ID	27004251401966	Medical ID	
Date	23/9/2025	Reason for MDT	

Medical Report	
Pathology: Bx-> IDC ER 8/8 PR 8/8 HER2 neg	
T N M S.M: Metsworkup: 2019 = NACTH FAC x4 Taxwol x12 2019 = left MRM Poor response to therapy LN 4/17 and extracapsular extension Perineural invasion	
Doctors' notes:	
Recommendations	
PORTH Aramidez + zoladex 11/2019 for continuation	
MDT DECISION	FOR CONTINUATION 2 MORE YEARS TAMOXIFEN

Name	د/ هاشم عبدالرحمن / خالد عبدالعزيز
Signature	 



Pathology Report

Name: هالة سلامة علي محمد

Age: 49 years.

Clinical data: Left breast cancer.

Specimen type: MRM.

Date: 28/10/2019

Lab. Number: 1101

Hospital Number: 1012/2019

Gross Description:

MRM specimen with skin covering; 19x14 cm, including nipple and areola.

Serial cuts revealed an ill-defined firm greyish white area located 3cm deep to skin 2.5 cm lateral to nipple in the upper outer quadrant, with least deep margin 2.5 cm

Axillary dissection revealed 15 nodules, up to 1.5x1 cm.

Microscopic Examination:

Histopathological examination of sections papered from the tumor bed site revealed residual viable tumor tissue, composed of invasive cords and tubules of moderately anaplastic ductal epithelial cells with inconspicuous in situ component and fair desmoplastic stroma.

Perineural invasion and lymphocytic tumor emboli were seen.

Necrosis was less than 10%.

The tumor was reaching the base of nipple without ulceration.

The skin of nipple, areola and resection margins were all free.

No axillary lymph nodes showed positive deposits in 4/17 with focal extracapsular extension.

Diagnosis:

Left MRM, post chemotherapy;

- Invasive duct carcinoma GII, minimal in situ, reaching base of the nipple.
- Positive perineural invasion and lymphatic tumor emboli.
- Less than 10% necrosis.
- Poor response to therapy.
- Positive 4/17 axillary lymph nodes with extracapsular extension.
- Tumor stage ypT ypN2.

Prof. Dr. Amal Haridy

Prof. Dr. Essam Ayad



Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m2081

Female : النوع
القاهرة : العنوان
09/04/2019 12:23 : تاريخ استلام العينة
16/04/2019 09:52 : تاريخ التقرير

حالة سلامة على سعد :
49 Y :
بيش اخذ العينة :
مركز اورام دار السلام :
مركز اورام دار السلام :
مركز اورام دار السلام :
مركز اورام دار السلام :

Primary Sample :

Paraffin Block

&PR & HER2 neu (ER&PR : Harvey scoring system - Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor (PR) (IE2) Rabbit monoclonal primary antibody.
Sample recieved was treated by: - VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.

Result :

ER: strong nuclear staining of 70 % of tumour cells
PR: strong nuclear staining of 70 % of tumour cells
HER2/neu protein over expression . NO membranous staining of tumour cells.

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 8/8)
PR: POSITIVE (SCORE 8/8)
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : NEGATIVE (CORE BIOPSY)

Pathologist:

د/اليناس رمزي

Lab Director: د/ نورا ماهر

10 El-sheikh Rehan Street, Abeideen, Cairo
Tel: (165)7948544-7950056 Fax: (202)7948544
Mobile : 0114429292
website: <http://www.healthlabs.net>
email: pathologycl@yahoo.com
facebook: [المركزية للمعمل](#)

* This Test Is Not Accredited By EGAC Nor Recognized By IL

يتم الاضطلاع بأصل المعينة لمدة 30 يوم من تاريخ استلامها

Page 1 of 1



ImmunohistoChemistry report

Report Number: m2081

Female :	النوع	49 Y	مرحلة سلامة على سعد	اسم المريض :
القاهرة :	العنوان			الجنس :
09/04/2019 12:23 :	تاريخ استلام العينة			تاريخ اخذ العينة :
16/04/2019 09:52 :	تاريخ التقرير			مطالب التحليل :
			مركز اورام دار السلام	عناية :
			مركز اورام دار السلام	

Primary Sample :

Block

ER & HER2 neu (ER&PR : Harvey scoring system - Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

Slide received was treated by : - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody. - CONFIRM anti-sterone receptor (PR) (IE2) Rabbit monoclonal primary antibody.
Slide received was treated by : - VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection ventana benchmark GX.

Result :

Strong nuclear staining of 70 % of tumour cells
Strong nuclear staining of 70 % of tumour cells
HER2/neu protein over expression. NO membrane staining at tumour cells.

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

POSITIVE (SCORE 8/8)
POSITIVE (SCORE 8/8)
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : NEGATIVE (CORE BIOPSY)

Pathologist :

د. أيمن رمزي

Lab Director: د. فريز ماهر



Patient Name: Hala Salama Ali Saad	Date : 18/10/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 53 Year(s)
Medical ID: 1012/2019	Pat. ID: 16193

**DIGITAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY
ULTRASOUND**

Indication:

- Follow-up after left MRM

Technique

- Right MLO and CC views
- Left MRM & breast ultrasound

Report:

- Left MRM:
 - Operative bed shows no mass or collection
 - No regional lymphadenopathy.
- Right Breast:
 - Heterogenous breast parenchyma (ACR b)
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
 - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left MRM status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal sonomammography of right breast (BIRADS 1)

Signature Dr. Nehal Hamdy

18/10/2023 1:06 PM

Name: *Hala Salama Ali* Date: *4/4/2019*

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

Known case of LABC.

1. Chest:

- Left breast edema with skin thickening and diffuse parenchymal infiltration.
- Enlarged left axillary lymph nodes largest measuring about 1.4 x 0.8 cm.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal appearance of the chest wall.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged in size with diffuse low CT attenuation denoting fatty infiltration. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- IUD is seen within the uterus.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic collections.

OPINION:

- ***Left breast edema.***
- ***No pulmonary or hepatic metastatic disease.***

Dr. Ahmed Rozeka, MSc *Dr. Amr Farouk, MD*

إسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/.....

تحية طيبة وبعد،

إيماء للطلب المقدم من بشأن تقرير طبي للمريض: هالة لاديه

بقسم رقم طبي

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته :

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج

ويط الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

Breast Ca

Tamoxifen

✓

تحريراً في

الوقت: التاريخ: / /

الطبيب المعالج

Dr. H. Ladi

يعتمد،

21/9/2026